



Частная клиника радиологии

- Магнитнорезонансная томография
- Компьютерная томография

RNI | Martin-Behaim Str. 4 | 63263 Neu-Isenburg

Уважаемые дамы и господа,

мы сообщаем о КТ органов грудной и брюшной полости с в/в контрастированием:

Г-жи Жерлициной Анастасии Станиславовны, г.р. 25.04.1976

Клинические данные: Лейомиосаркома матки, известное метастазирование в печени и перитонеально

Клиническая задача: актуальный статус?

Заключение:

Грудная клетка:

При введении контрастного вещества правильная перфузия супрааортальных и медиастинальных сосудов. Правильная перфузия полостей сердца. Тонкий перикардиальный выпот, больше справа, достигает толщины слоя до 0,9 см; ориентировочное измерение плотности показывает показатели между 0 и 10 HU, таким образом здесь можно описать серозный перикардиальный выпот.

В торакальных отделах признаков патологических лимфатических узлов нет, медиастинальных или хиларных умножений тканей нет.

Грудная стенка без патологии, в особенности паренхима молочных желез без признаков локализованных или других объёмных образований.

Маленькие субплевральные буллы над апикальными отделами легких, единичные интрапаренхиматозные буллы / диф. диагноз центрилобулярная эмфизема – в анамнезе курение? Легочная паренхима без признаков подозрительных на злокачественные фокальных или интерстициальных очагов. На коротком отрезке утолщение стенки вдоль право-латеральной окружности трахеи ок. 8,5 см проксимально кия трахеи; утолщение стенки макс. краниокаудальным поперечным размером до 0,6 см и глубиной до ок. 0,3 см. Гладкое контурирование и на КТ скорее гиподенсная визуализация, таким образом здесь определяется маленькая муральная липома трахеи (напр., серия 4, изобр. 86). Трахеобронхиальные структуры в целом не утолщены.

Торакальный скелет соответствует возрасту и без признаков злокачественной инфильтрации.

Брюшная полость:

Печень с большой опухолевой массой при преимущественно сливающихся метастазах печени в обеих долях; так, в правой доле печени метастазы достигают аксиального поперечного размера до 19 x 12 см при макс. краниокаудальном размере до 17 см. В воротах печени начинающаяся компрессия общего печёночного протока и как следствие вторичный внутripечёночный холестаз в обеих долях печени (напр., серия 5, изобр. 265). Перфузия непораженной паренхимы печени правильная. Вдоль венробазальной окружности правой доли печени (сегмент 4) начинающийся экзофитный рост метастазов печени.

Селезенка и надпочечники не утолщены согласно снимкам.

Поджелудочная железа перфузируется гомогенно, патологического расширения вирсунгова протока нет. Каудально хвоста поджелудочной железы и дорсально желудка негомогенно перфузированное объёмное образование с макс. поперечным размером до 5,2 см и краниокаудальным размером до 6,1 см. Билатеральное правильное накопление контраста структур коркового и мозгового вещества почек, к моменту обследования мочеточники по всему ходу не утолщены, признаков патологического расширения нет. Визуализация мочевого пузыря без особенностей.

В тазу признак 2-х объёмных образований; сразу дорсоапикально матки со здесь подозрением на соединение *per continuitatem* и, согласно морфологической картине, оценивается как субсерозная миома (напр., серия 5, изобр. 494), до 6 см аксиальным поперечным размером и до 5 см краниокаудальным поперечным размером. Кроме этого, признак негомогенного перфузированного объёмного образования на вентральном уровне таза, которое достигает на аксиальном уровне поперечного размера до 8,5 см при краниокаудальном распространении до 10 см.

Визуализация мочевого пузыря без особенностей. Ректосигмоидный отдел и остальная ободочная кишка без признаков локализованных или других утолщений стенки.

Единичные реактивные лимфатические узлы парааортально, выражено на уровне ворот почки (серия 5, изобр. 384), в остальных патологических лимфатических узлов в отделах брюшной полости нет. На момент обследования значительного асцита нет.

Осевой скелет без признаков злокачественной инфильтрации.

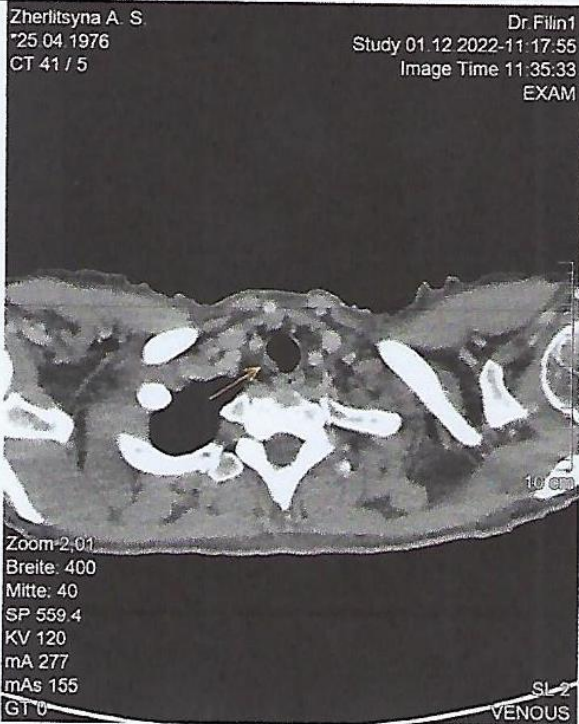
Эпикрическое заключение:

В первую очередь определяется печеночное метастазирование с критериями высокой динамики при большом опухолевом объеме и диффузно сливающимися центрами; ранее как пример приведен метастаз в правой доли печени, частично начинающийся экзофитный рост вдоль венробазальной окружности правой доли печени, а также начинающаяся компрессия желчных путей при раннем внутripеченочном холестаза. Эквивалентно перфузированные объемные образования каудально хвоста поджелудочной железы и в малом тазу с неомогенным узором перфузии при диф. диагнозе перитониальные метастазы. Дополнительно в малом тазу объемное образование с гладкими контурами, которое вероятнее можно оценить как субсерозную миому матки.

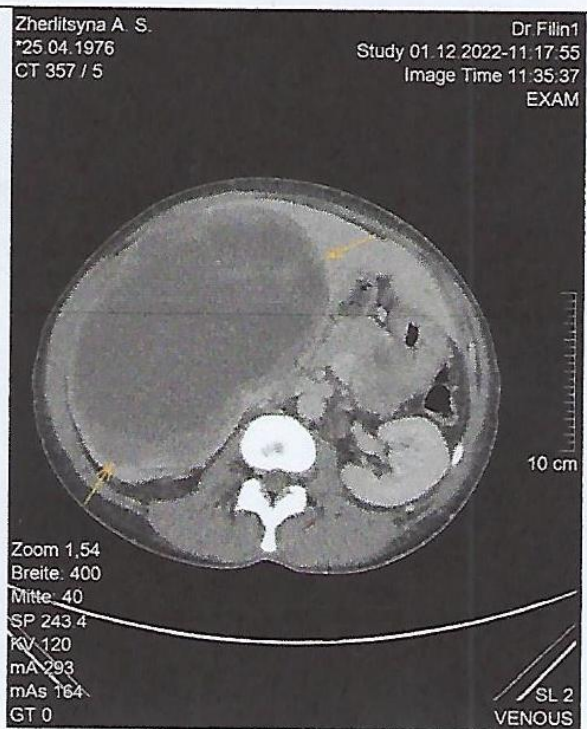
Пulьмональных метастазов нет, патологических лимфатических узлов в торакальных отделах нет. Тонкий перикардальный выпот с серозными показателями плотности – следует сделать клиническую корреляцию.

В соответствии с морфологической картиной доброкачественное объемное образование трахеи в средней трети и вдоль праволатеральной окружности как описано выше при диф. диагнозе напр. липома.

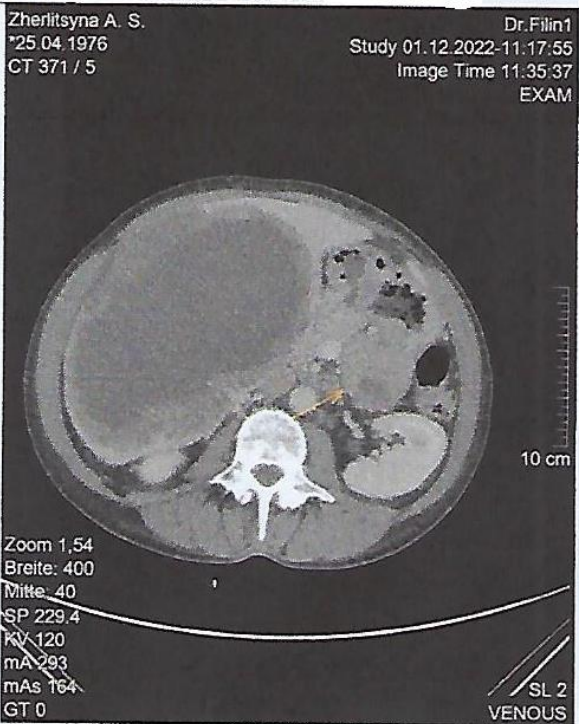
Злокачественной инфильтрации осевого скелета нет.



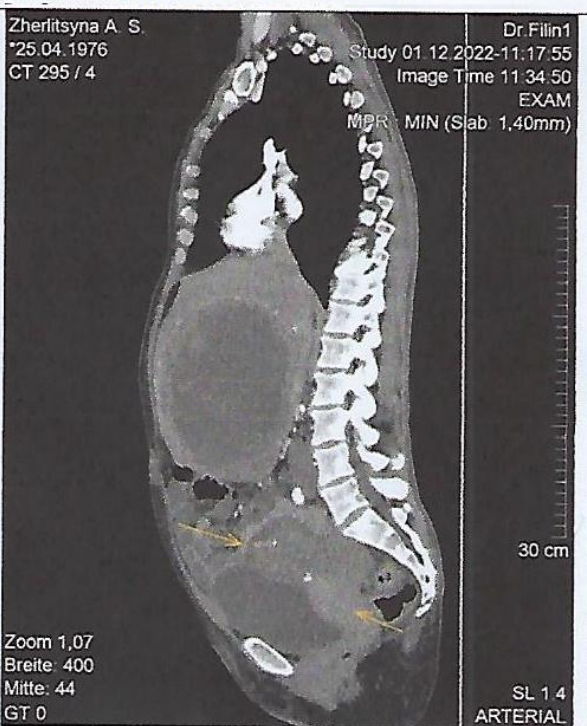
Доброкачественное уплотнение стенки трахеи



Референтный метастаз в печени



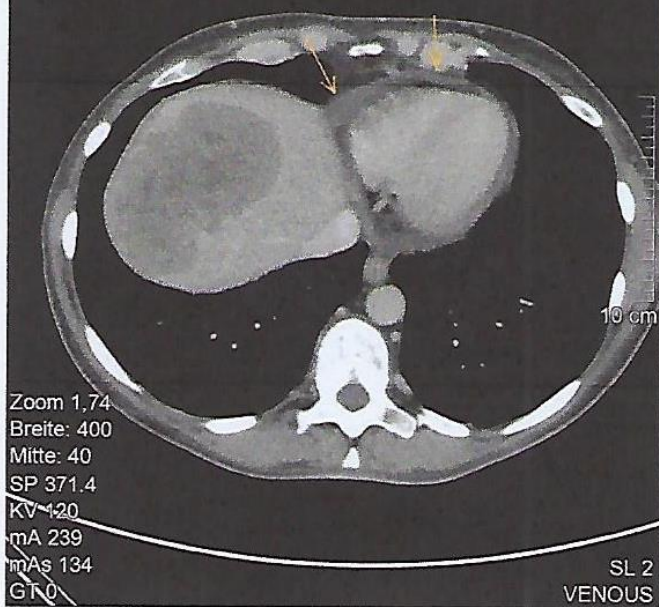
Инфрапанкреатический метастаз



Метастаз в тазу

Zherlitsyna A. S.
*25.04.1976
CT 229 / 5

Dr. Filin1
Study 01.12.2022-11:17:55
Image Time 11:35:35
EXAM



Перикардиальный выпот

ПД др. мед. А. Маатаоуи